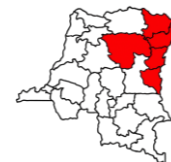




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°108/MVEBDB/30/08/2026

Date de rapportage : 30 août 2026

Date de publication : 31 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24, 59 nouveaux cas confirmés dont 19 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (44 cas), du Nord-Kivu (8 cas), Haut Uélé (6) et Bas Uélé (1). De plus, 20 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h.

CUMUL DES CAS 6 100	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 950	LETALITE 48,4%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 814	CUMUL DES GUÉRIS 1 383	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 86,3 %
--	--	-------------------------------------	---	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au terme de la journée du 30 août 2026, **59 nouveaux cas confirmés** dont **19 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans les provinces de l'Ituri (**44 cas**), Nord-Kivu (**8**), Haut Uélé (**6**) et Bas Uélé (**1**).

Par ailleurs, **17 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (13 en Ituri, 3 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo). Cependant, **20 décès intra-CTE** ont été malheureusement rapportés, dont 15 en Ituri, 2 au Haut Uélé, 2 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo, portant **le nombre des décès du jour à 39**.

Jusqu'au 30 août 2026, **6 100 cas confirmés** dont **2 950 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,4 %**. Environ **82,3 %** des cas confirmés se concentrent en Ituri, faisant d'elle l'épicentre, de même, **74,6 %** des nouveaux cas rapportés sont issus de cette province.

De plus, 60 des 151 (39,7%) zones de santé des six provinces restent affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 30 août 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	44	5016	2 274	45,3%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	8	836	566	67,7%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	6	222	97	43,7%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	0	19	9	47,4%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	1	4	3	75,0%	3/11(27,3%)
Total	59	6 100	2 950	48,4%	60/151 (39,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 30 août 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5016	2274	45,3%	44	12	15	27
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	161	36	22,4%	3	1		1
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1397	437	31,3%	5	0		0
Damas	28	9	32,1%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	76	30	39,5%	2	0		0
Gethy	6	2	33,3%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	78	51	65,4%	4	3		3
Lita	218	119	54,6%				0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	22	5	22,7%	3	1		1
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	36	21	58,3%				0
Mangala	246	127	51,6%	10	5		5
Mongbwalu	610	285	46,7%	1	0		0
Nia-Nia	215	113	52,6%	1	0		0
Nizi	662	261	39,4%	10	1		1
Nyankunde	124	35	28,2%				0
Rimba	10	4	40,0%				0

Rwampara	950	338	35,6%	5	1		1
Tchomia	57	25	43,9%				0
A ventiler**	NA	329	NA	NA	NA	15	15
Nord-Kivu	836	566	67,7%	8	5	2	7
Beni	138	100	72,5%	2	2		2
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	165	124	75,2%	1	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	390	257	65,9%	1	0	1	1
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	5	4	80,0%	2	2		2
Manguredjipa	1	0	0,0%				0
Masereka	9	4	44,4%	1	0		0
Musienene	79	46	58,2%	1	1		1
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	6	85,7%				0
Vuhovi	6	3	50,0%			1	1
Haut-Uélé	222	97	43,7%	6	1	2	3
Boma Mangbetu	27	14	51,9%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	81	33	40,7%				0
Pawa	33	19	57,6%	5	1	2	3
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	77	30	39,0%	1	0	0	0
Tshopo	19	9	47,4%	0	0	1	1
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	9	5	55,6%	0	0	1	1
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	4	3	75,0%	1	1	0	1
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	2	2	100,0%	1	1	0	1
Total	6100	2950	48,4%	59	19	20	39

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 30 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	17	0	17	9	0	8	0	9	4
Bas Uélé	14	4	18	1	3	13	1	4	0
Ituri	656	45	701	125	43	488	2	168	105
Nord-Kivu	755	29	784	47	28	664	1	75	23
Sud-Kivu	ND	ND	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	108	0	108	2	0	106	0	2	1
Total Général	1550	78	1 628	184	74	1279	4	258	133

ND : Non disponible.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

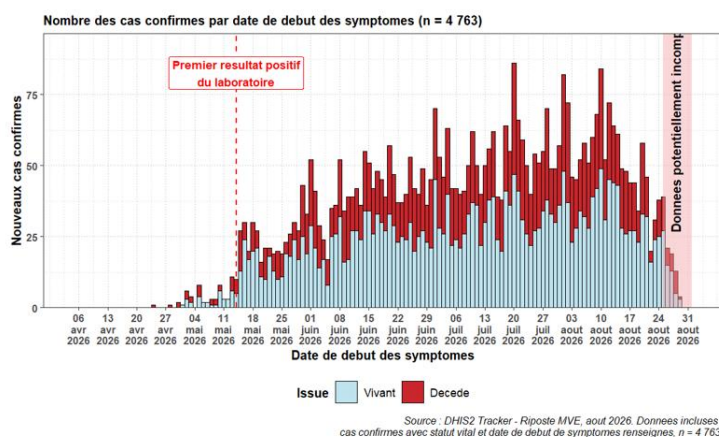
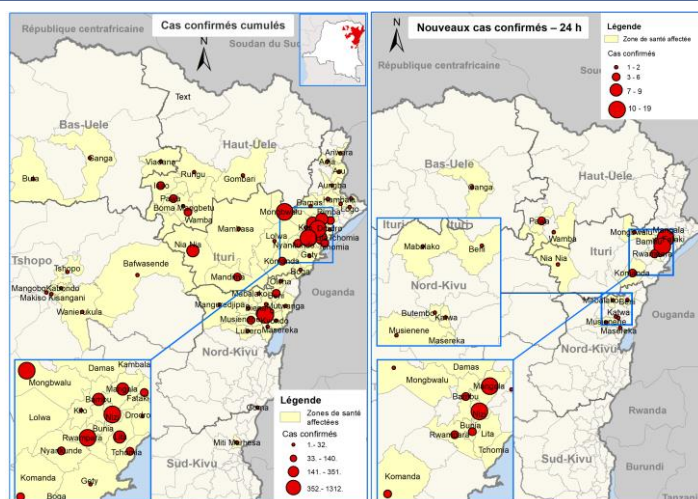


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1. Coordination

1.1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

1.1.2. Surveillance épidémiologique

1.1.3. Principales Actions

Au total, 1 628 alertes ont été enregistrées en date du 30 août 2026, dans 5 des 6 provinces touchées, 1 541 (94,7%) ont été vérifiées. Les 258 cas suspects validés ont tous été investigués (100 %) et 133 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 86,3 % (21 002 vus sur 24 330 à suivre), au-delà du seuil de 85 % : Ituri 89,4 % (11 829/13 235), Tshopo 100% (455/455), Nord-Kivu 84,8 % (7 529/8 882), Haut Uélé 68,5% (1 001/1 461) et Bas Uélé 63,3% (188/297).

1.1.4. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans les provinces du Bas et Haut Uélé, lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Dix (10) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : six au Nord-Kivu, dont cinq validées et référées aux CT (PoC Mukulia/ZS Beni, PoC Matombo/ZS Oicha, PoC Kangote/ZS Butembo et PoC Foner Kasindi/ZS Mutwanga) ; une en Ituri, au PoC Irumu (ZS Nyankunde), validée et référée à l'HGR Nyankunde ; trois au Bas-Uélé (PK 12 Isiro/ZS Viadana et PK 65 Sukisa/ZS Koteli), toutes invalidées après investigation.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 30 août 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	96 % (58/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	100 % (17/17)	36 % (4/11)	55 % (11/20)	83,7 % (113/135)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	124 031	82 924	6 609	22 359	11 880	6 680	254 483
% des voyageurs screenés	99 %	97 %	98 %	99 %	99 %	98 %	98,2 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	98 %	97 %	98 %	99 %	99 %	98 %	97,9 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	97 %	100 %	76,8 %	99 %	98 %	96,6 %
Nombre d'alertes notifiées	1	6	0	0	0	3	10
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	5	0	0	0	0	6
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (1/1)	100 % (5/5)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	100 % (6/6)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)
% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (1/1)	100 % (5/5)	NA (0/0)	NA (0/0)	NA (0/0)	100 % (3/3)	100 % (9/9)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC non optimale et complétude de rapportage insuffisante (113 rapports sur 135 : 83,7 %), avec des niveaux faibles au Haut-Uélé (36 %), au Bas-Uélé (55 %) et au Sud-Kivu (55,5 %). **En Ituri**, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption ; le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel pour raisons sécuritaires et le PoC Pont Ituri n'a pas rapporté. **Au Haut-Uélé**, 6 PoC (Dusu, Apodo, PK10 route Poko, Gossamu, Salisa et Aungba) n'ont pas rapporté et le PoE de Doko n'opère pas les samedis et dimanches. **À la Tshopo**, la proportion des voyageurs sensibilisés reste faible (76,8 %).

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- Ituri : 44 nouveaux résultats positifs** (32 vivants et 12 décès) sur 311 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,1 %**).

- **Nord-Kivu : 8 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 5 décès) sur 199 échantillons analysés (**positivité de 4,0%**).
- **Haut-Uélé : 6 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 1 décès) sur 17 échantillons analysés (**positivité : 35,2%**).
- **Bas-Uélé : 1 swab reçu et testé**, le résultat est revenu positif.
- **Tshopo : 2 nouveaux échantillons** ont été reçus, tous sont revenus négatifs.

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 18 rings ont été ouverts sur les 41 identifiés (47 %), 94 ménages décontaminés sur 120 identifiés (78,3 %) et 4 FOSA sur 4 (100 %) ; 62 EDS réalisées sur 83 alertes et 48 corps swabés (9 échecs).
- **Au Nord-Kivu**, 11 rings ouverts, 4 ménages décontaminés sur 14 identifiés (28 %) et 16 ESS décontaminées sur 20 (80 %) ; 7 évaluations FOSA réalisées avec un score moyen de 53,3 %. 56 corps swabés et 53 EDS réalisés.
- **À la Tshopo**, décontamination de 3 locaux, 1 latrine et 1 douche de la Polyclinique Millénaire, de 2 locaux et 1 latrine du CSR Lombale et du pavillon de MI de l'HGR Bafwasende ; briefing de 70 prestataires et formation de 64 hygiénistes ; 9 corps swabés et 9 EDS réalisés.
- **Au Haut-Uélé**, 1 ring ouvert et 4 décontaminations de lieux de séjour sur 21 ; 4 alertes EDS reçues, 4 corps swabés et 4 EDS réalisés (Isiro 2, Pawa 2).
- **Au Bas-Uélé**, réception d'intrants PCI dans les ZS de Bili, Titule et Bondo ; 3 corps swabés.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : **en Ituri**, l'ouverture des rings demeure non optimale (47 %) et la décontamination des ménages non complètes (78,3 %) ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Nizi et manque de mobilité à Komanda, Bambu, Mandima et Mangala. **Au Nord-Kivu**, seuls 4 ménages ont été décontaminés sur 14 identifiés (28 %). **À la Tshopo**, insuffisance d'EPI dans les ESS et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 75 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées et 81 sorties dont 13 guéris. Ainsi, 524 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 53,6 %.
- **Au Nord-Kivu**, 75 nouvelles admissions et 54 sorties dont 3 guéris ; 282 patients sont hospitalisés et le taux d'occupation global des lits en CTE/CT est en sursaturation (128,2 % ; 282/220).
- **À la Tshopo**, aucune nouvelle admission n'a été enregistrée. Sept sorties rapportées dont 1 guéri, 7 patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 32,0%.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et saturation : en Ituri, les CTE de Bambu (confirmés) et de Nizi (suspects) ainsi que les CT de Kigonze et de Lolwa (suspects) sont saturés ; au Haut-Uélé, absence de CTE aux normes à Isiro et Wamba ; au Bas-Uélé, absence de CTE aux normes et de partenaire d'appui à la prise en charge ; à la Tshopo, faible capacité d'accueil du CTE et absence de CTE normé à Bafwasende.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 9 personnes dont 6 femmes ont été touchées, dans la préparation de familles pour le suivi régulier ; 31 personnes touchées dont 20 femmes pour le listage de contacts et la décontamination de ménages dans la zone de santé de Nizi ; sensibilisation autour d'un cas confirmé touche 42 personnes dont 28 femmes dans la zone de santé de Nia-Nia.
- Actions de communication autour de 9 cas confirmés récents (Nizi, Kilo, Nia-Nia, Afia, Tchomia et Sabe) touchant 185 personnes ; listage de 37 contacts à Kilo, 39 à Rwampara, 112 à Lolwa et 14 à Nia-Nia avec l'appui de la CREC ; 78 personnes sensibilisées à l'adhésion à l'EDS autour de 28 corps sans vie
- **Au Nord-Kivu**, 35 activités CREC dont 9 causeries éducatives, 6 VAD et 1 sensibilisation de masse ont été réalisés ; 7 rumeurs clarifiées sur 8 identifiées et 2 incidents communautaires résolus.
- **Au Haut-Uélé**, intensification de la sensibilisation de masse dans les églises des ZS touchées ; 2 causeries éducatives dans les ménages ; dialogue communautaire à Pawa (252 personnes) et à Isiro ; 41 visites à domicile ; 1 120 ménages touchés à Isiro ; recherche active de 3 PPL évadés
- **À la Tshopo**, sensibilisation de 14 229 personnes (8 130 femmes et 6 099 hommes) dans les confessions religieuses ; dialogue communautaire à Bafwasende (48 personnes) ; briefing de 64 SUPRO ; 3 articles publiés en ligne ; 1 rumeur clarifiée.
- **Au Bas-Uélé**, début de la sensibilisation des forces vives et de la société civile à Buta et intensification de la sensibilisation dans les ZS de Bondo et Ganga.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : en Ituri, 20 refus d'isolement, 9 corps non swabés pour résistance communautaire et résistances à Bambu, Fataki et Mandima ; au Haut-Uélé, résistances lors des dépouilles et 10 aires de santé de résistance cartographiées sur 24.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 25 cas parmi les nouveaux confirmés du jour et 138 des 231 cas confirmés en cours de suivi (59,7 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 39 des 74 nouveaux suspects (52,7 %) ; 27 ménages accompagnés, 47 PPL soutenus, 63 annonces de résultats dont 25 positifs et 7 guéris sur 10 suivis en communauté (70 %).
- **À la Tshopo**, 4 cas confirmés en cours de suivi et 3 nouveaux suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 3 résultats de laboratoire annoncés ; 21 contacts soutenus, 4 accompagnants et 24 membres de ménages appuyés ; 2 guéris ont intégré les équipes de riposte.
- **Au Bas-Uélé**, 1 résultat de laboratoire annoncé et 3 PPL ont bénéficié d'interventions SMSPS.

1.7.2. Défis

En Ituri, faible couverture des interventions SMSPS autour des décès communautaires à Nizi, Lita et Komanda ; couverture limitée à 6 des 11 ZS ayant notifié (56 %). Au Nord-Kivu, absence de rapportage des données du pilier. À la Tshopo, absence de prestataires SMSPS à Wanie-Rukula et Bafwasende

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

Dans la Tshopo, suivi de la construction des sites d'isolement de Madula, Kabondo et Konga-Konga ainsi que du CTE de grande capacité ; appui à la mobilité des piliers PCI, PECH, Communication, PoE/PoC et vaccination. Au Bas-Uélé, déploiement des équipes pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active ; rupture signalée de gel hydroalcoolique, blouses à usage unique, dispositifs de lavage des mains et tabliers réutilisables. En Ituri, 27 ambulances sans alimentation dans 6 zones et 3 ambulances en panne

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- **Au Haut-Uélé**, interception par la police, au PK 8 de Pawa, d'un corps sans vie arraché au CTE de Pawa. À la Tshopo, affectation de 2 unités de police pour la sécurisation du laboratoire.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : au Haut-Uélé, le corps sans vie intercepté au PoC de Magambe (ZS Isiro) a été relâché par la sécurité sans avoir pu être swabé. Au Nord-Kivu, l'insécurité persiste dans les zones d'enterrement et la route menant au cimetière de Bundji (ZS de Beni) reste impraticable.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions.

En Ituri, formation de 48 relais communautaires de la ZS de Bunia sur les thématiques de la PSE (12 hommes et 36 femmes) ; sensibilisation de 40 personnes dans l'AS Lembabo/Mudzi Maria et de 65 volontaires de la Croix-Rouge à Aru (25 femmes et 40 hommes) ; poursuite de l'affichage des messages et de la distribution de dépliants dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara et Mongbwalu.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement et seuls 2 partenaires (OMS et IMC) rapportent leurs activités PSEA ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- La transmission continue de la MVE, avec 59 nouveaux cas dont 19 décès communautaires et 20 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 6 100 cas confirmés et 2 950 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 82,2 % des cas confirmés cumulés et 74,6% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100%) des cas suspects investigués et le taux de suivi (86,3%) supérieur au seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd